OBSTETRÍCIA

Sangramento na primeira metade da gestação

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

12 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO · OBSTETRÍCIA

Sangramento da primeira metade da gestação

Abortamento · gestação ectópica · doença trofoblástica gestacional

1. Causas de sangramento da primeira metade.
2. Sinais e sintomas de cada quadro.
3. Exames complementares que auxiliam no diagnóstico.
4. Exame físico × avaliação ultrassonográfica.
5. Conduta terapêutica.
6. Aspectos sociais e emocionais na vivência do aborto.

FORMATO **RESUMO** · TEMA **HEMORRAGIA DA PRIMEIRA METADE** · **2026**

1

Definições e conceitos-chave

O que precisa estar fixado antes de qualquer raciocínio diagnóstico.

Hemorragia da primeira metade = sangramento até a 20ª–22ª semana. Três causas obstétricas concentram quase todos os casos:

Entidade	Frequência	Definição essencial
Abortamento	~10% das gestações clinicamente reconhecidas (até 31% incluindo perdas precoces)	Interrupção antes da viabilidade: < 20–22 semanas ou < 500 g[1]
Gestação ectópica	1% a 2%; 90–95% tubárias	Implantação fora da cavidade uterina; principal causa de morte materna no 1º trimestre[6]
Doença trofoblástica	1:200–400 gestações no Brasil	Proliferação anômala do trofoblasto, com β-hCG como marcador tumoral[7]

Tabela 1 — As três causas obstétricas. A incidência brasileira de DTG é 5 a 10 vezes maior que a europeia.

Classificação do abortamento — três eixos independentes: cronologia (precoce até 12 semanas, respondendo por 80% dos casos; tardio a partir de 13), intenção (espontâneo ou induzido) e condições técnicas (seguro ou inseguro)[1].

> **PONTO-CHAVE**
> A primeira pergunta não é "qual das três?", e sim **"esta paciente está estável?"**. Instabilidade + atraso menstrual = ectópica rota até prova em contrário, e a prova se faz na sala cirúrgica. Lembre também das causas não obstétricas: cervicite, pólipo, ectópia sangrante, laceração e **câncer de colo** — por isso **toda gestante que sangra merece exame especular**.

A figura 1 resume a sequência de decisões da abordagem inicial.

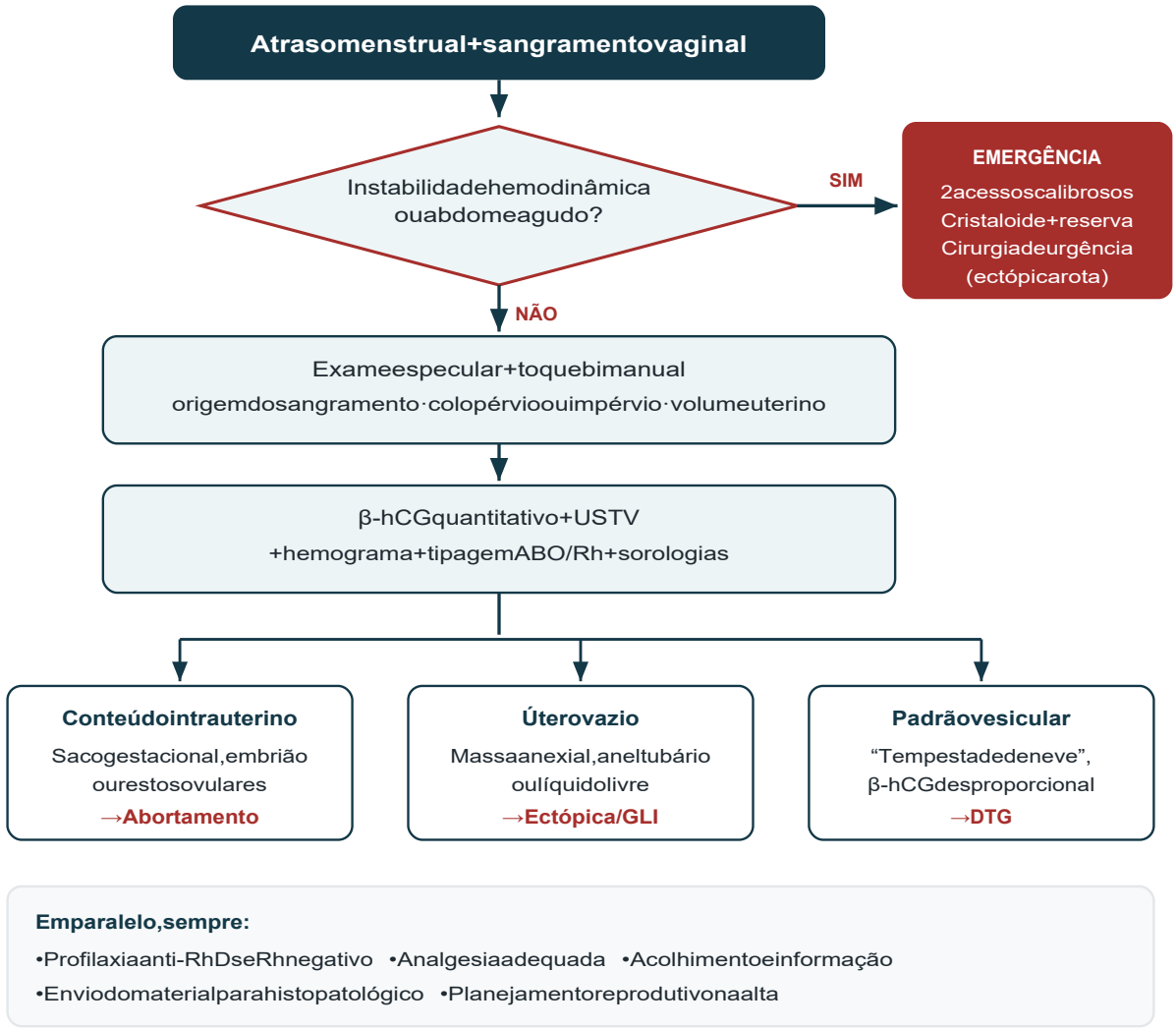


Figura 1 — Abordagem inicial do sangramento da primeira metade. A triagem de estabilidade precede qualquer exame. GLI: gestação de localização indeterminada; DTG: doença trofoblástica gestacional.

2

Fisiopatologia essencial

Três cadeias causais que explicam toda a semiologia.

2.1 Abortamento

Anomalia cromossômica (50–60% dos casos precoces, trissomias autossômicas à frente)[1] → falha do desenvolvimento embrionário → queda da produção trofoblástica de hCG → involução do corpo lúteo e **queda da progesterona**. Daqui saem duas vias simultâneas:

- **Via hemorrágica** — necrose e descolamento decidual, abertura de seios venosos → *sangramento*;
- **Via contrátil** — liberação de prostaglandinas → contração miometrial → *cólica e dilatação cervical* → expulsão.

Consequência prática: **sangramento sem cólica com colo fechado** = via contrátil não iniciada (ameaça ou retido); **cólica intensa com colo pérvio** = processo em curso, irreversível.

2.2 Gestação ectópica

Atraso do transporte tubário (salpingite prévia — sobretudo por clamídia — cirurgia tubária, endometriose, aderências) → blastocisto adquire capacidade de implantação ainda dentro da tuba → como a tuba não tem décidua verdadeira nem distensibilidade, o trofoblasto invade a parede muscular e os vasos. Três desfechos: **aborto tubário**, **reabsorção espontânea** (base da conduta expectante) e **rotura com hemoperitônio**.

> **RACIOCÍNIO CLÍNICO**
> O sangramento vaginal da ectópica é **escasso e escuro** porque não vem da lesão — vem da décidua uterina descamando por queda hormonal. A hemorragia verdadeira ocorre *dentro do abdome*. Daí a discrepância clássica: **dor desproporcional ao sangramento**.

2.3 Doença trofoblástica

Tudo decorre da **proporção de genoma paterno**: quanto mais paterno, menos embrião e mais proliferação trofoblástica — e, portanto, mais hCG, mais complicações clínicas e mais risco de neoplasia (figura 2).

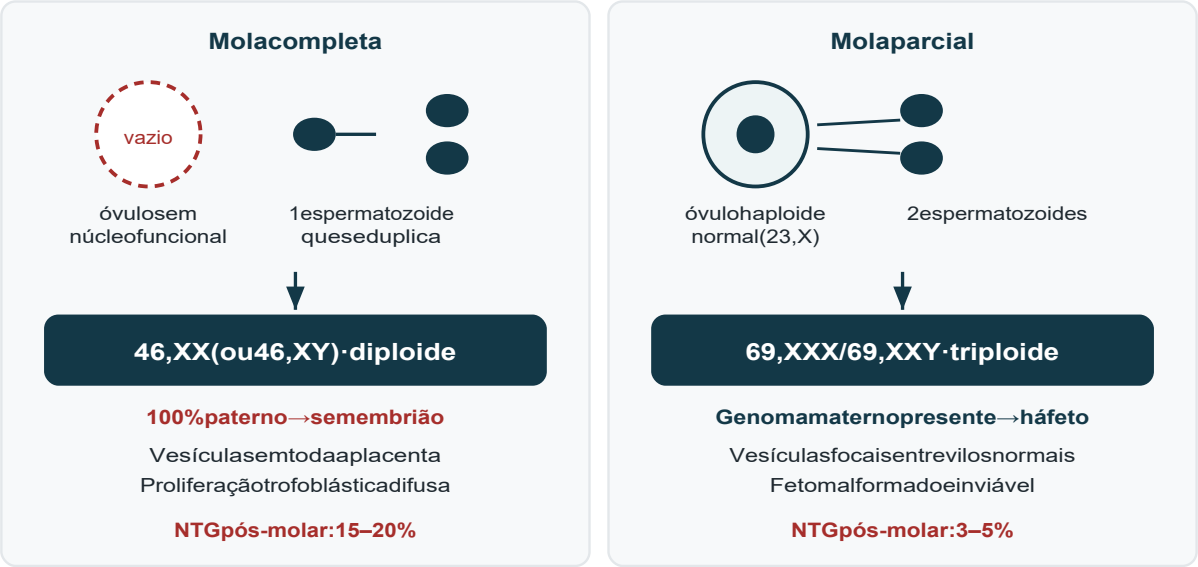


Figura 2 — Origem citogenética das molas hidatiformes. A proporção de genoma paterno determina se há embrião e quão exuberante é a proliferação trofoblástica — e, por consequência, o risco de progressão para neoplasia[7].

> **MACETE**
> **Completa = só pai** (46,XX androgenética): sem embrião, proliferação difusa, hCG altíssimo, NTG em 15–20%. **Parcial = pai em dobro + mãe** (69,XXX triploide): tem feto inviável, proliferação focal, hCG menor, NTG em 3–5%. A parcial é quase sempre confundida com abortamento retido[7].

3

Quadro clínico

Quatro variáveis de beira de leito bastam para classificar o abortamento.

Forma	Sangramento	Dor	Colo	USTV	Conduta
Ameaça	Discreto	Discreta ou ausente	Fechado	Embrião com vitalidade ± descolamento ovular	Analgesia + expectante

Forma	Sangramento	Dor	Colo	USTV	Conduta
Inevitável	Presente, por vezes abundante	Cólicas sempre	Entreaberto	Ovo deformado, hematoma retro-ovular, ovo baixo	Volume, analgesia, esvaziamento
Incompleto	Presente, por vezes abundante	Cólicas sempre	Pérvio	Conteúdo amorfo e heterogêneo	AMIU ou curetagem
Completo	Ausente ou discreto	Ausente	Fechado	Útero vazio ou com coágulos	Expectante — sem intervenção
Retido	Ausente ou mínimo	Ausente	Fechado	Critério de inviabilidade preenchido	Expectante até 4 semanas, misoprostol ou aspiração
Infectado	Variável	Intensa e contínua	Pérvio e doloroso	Restos ovulares ou coágulos	Antibiótico EV + esvaziamento mecânico

Tabela 2 — Formas clínicas do abortamento, conforme o Protocolo FEBRASGO nº 17[1]. Febre e secreção purulenta reclassificam qualquer forma para infectado.

MACETE

O colo está aberto? Se sim, a gestação está perdida — falta saber se já saiu tudo (completo), se ainda há material (incompleto) ou se está saindo (inevitável). **Se está fechado**, pode estar viva (ameaça), morta e retida (retido) ou já resolvida (completo).

3.1 Gestação ectópica

Tríade clássica: **atraso menstrual + dor abdominal + sangramento escasso**. Ao exame: dor à mobilização do colo, massa anexial dolorosa, **útero menor que o esperado**, Blumberg, **sinal de Laffont** (dor referida no ombro por irritação diafragmática), sinal de Proust (abaulamento doloroso do fundo de saco), lipotímia.

3.2 Doença trofoblástica

Sangramento de repetição (75–95%), **útero maior que o esperado** (20–50%), cistos teca-luteínicos bilaterais (~20%, por efeito LH-*like* do hCG), hiperêmese, **hipertireoidismo** (~2–5%, por homologia da subunidade alfa do hCG com o TSH), **pré-eclâmpsia antes de 20 semanas** e eliminação de vesículas (~25%)[7].

PEGADINHA DE PROVA

Pré-eclâmpsia antes da 20ª semana é mola até prova em contrário. Cistos teca-luteínicos regridem com a negativação do hCG — não se operam, exceto em torção ou rotura. Dor no ombro em mulher com atraso menstrual não é contratura: é hemoperitônio.

4

Diagnóstico

Dois exames que só decidem quando lidos juntos.

4.1 β-hCG quantitativo

- **Valor absoluto** — só faz sentido comparado à idade gestacional e à imagem. Alto demais: DTG ou gemelaridade (> 100.000 sugere mola completa). Baixo: erro de datação, ectópica ou perda em curso.

- **Cinética em 48 h** — gestação tópica viável sobe **≥ 35%**[6]. Ascensão insuficiente indica gestação anormal, mas *não diz onde ela está*.
- **Zona discriminatória** — historicamente 1.500–2.000; hoje elevada para **3.500 mUI/mL**, justamente para não interromper gestações tópicas viáveis ainda não visíveis[6,12].

4.2 Ultrassonografia transvaginal

Sequência normal: **saco gestacional** (~4–5 sem) → **vesícula vitelínica** (~5–5,5 sem) → **embrião com BCF** (~6 sem). Só garante gestação tópica a visualização de saco com vesícula vitelínica ou embrião.

> **ATENÇÃO — PSEUDOSSACO**
> Saco verdadeiro: **excêntrico**, duplo halo decidual, com vesícula vitelínica. Pseudossaco: **central**, contorno único, sem estruturas embrionárias — clássico na ectópica. Confundi-los é a rota para deixar uma ectópica romper.

Critérios ultrassonográficos de abortamento retido[1,2]

- Saco gestacional sem vesícula vitelínica nem embrião, com diâmetro médio **≥ 25 mm**;
- Embrião com CCN **≥ 7 mm** sem atividade cardíaca;
- Sem embrião com BCF **2 semanas após** exame com saco gestacional vazio;
- Sem embrião com BCF **≥ 11 dias após** exame com saco contendo vesícula vitelínica.

> **PEGADINHA DE PROVA**
> Saco de 20 mm sem embrião ou embrião de 5 mm sem BCF **não** fecham diagnóstico: a conduta é **repetir a USTV**. Os critérios foram desenhados para altíssima **especificidade** — o dano de interromper uma gestação viável é assimétrico.

4.3 Achados na ectópica e na DTG

- **Ectópica** — útero vazio + **massa anexial extraovariana** (anel tubário ou "sinal do bagel", hematossalpinge), líquido livre com ecos; embrião vivo extrauterino é *patognomônico*, mas raro.
- **Gestação de localização indeterminada (GLI)** — β-hCG positivo sem gestação tópica nem massa anexial. Não é diagnóstico: é estado de incerteza. Repetir β-hCG em 48 h e USTV seriada. Nunca tratar **às cegas.**
- **DTG** — massa ecogênica com múltiplas áreas anecóicas ("tempestade de neve"), sem embrião na MHC. A US faz ~90% dos diagnósticos, mas perde 25–50% das molas muito precoces e ~70% das parciais de 1º trimestre[7].

4.4 Exames obrigatórios em todos os casos

β-hCG quantitativo, USTV, hemograma e **tipagem sanguínea com fator Rh** (define profilaxia anti-RhD e antecipa hemotransfusão); sorologias, sobretudo sífilis, com testes rápidos para HIV e hepatites[1]. Na suspeita de mola, acrescentar **TSH e T4 livre** e radiografia de tórax[7].

5

Diagnóstico diferencial

Exame físico e ultrassonografia respondem a perguntas diferentes.

O **exame físico** responde *o que está acontecendo agora* — há instabilidade? o processo de expulsão começou? há infecção ou irritação peritoneal? — e define **urgência e forma clínica**. A **ultrassonografia** responde *onde está e como está a gestação* e define **topografia e viabilidade**. Consequência direta: no

abortamento inevitável e no infectado a US não é necessária e não pode retardar o tratamento[1]; e na suspeita de ectópica com paciente instável, o exame físico basta para indicar cirurgia.

Parâmetro	Abortamento	Gestação ectópica	Doença trofoblástica
Sangramento	Vermelho vivo, moderado a intenso, com coágulos	Escasso, escuro, intermitente	Intermitente, de repetição, às vezes com vesículas
Dor	Cólica rítmica central	Lateralizada, contínua; pode irradiar para o ombro	Geralmente ausente
Volume uterino	Compatível ou menor	**Menor** que o esperado	**Maior** que o esperado
Colo	Pérvio ou impérvio — define a forma	Impérvio; dor à mobilização	Impérvio, exceto na expulsão de vesículas
Anexos	Sem alterações	Massa anexial dolorosa	Cistos teca-luteínicos bilaterais
β-hCG	Compatível ou em queda	Ascensão < 35% em 48 h	Muito acima do esperado
USTV	Conteúdo intrauterino	Útero vazio + massa anexial	Padrão vesicular sem embrião (MHC)
Sinal de alarme	Febre, secreção purulenta	Blumberg, dor no ombro, lipotímia	Hipertensão antes de 20 semanas

Tabela 3 — Comparação das três entidades. O eixo do volume uterino resume tudo: menor → ectópica; compatível → aborta-***mento; maior** → **mola**.*

Não esquecer: causas cervicais e vaginais (só o especular identifica), sangramento de implantação, hematoma subcoriônico, **gestação heterotópica** (ver gestação tópica não exclui ectópica após reprodução assistida) e gestação gemelar com mola completa e feto coexistente[7].

6

Tratamento

Reconhecer gravidade → medidas iniciais → primeira linha → falha → monitorização → alta.

6.1 Abortamento

Conduta individualizada por gravidade, idade gestacional, forma clínica e **preferência da paciente** — nas formas não complicadas, expectante, medicamentosa e cirúrgica têm eficácia comparável e a decisão compartilhada melhora a experiência do cuidado[1,5].

Misoprostol

ANÁLOGO DA PROSTAGLANDINA E1 — MATURAÇÃO CERVICAL E CONTRAÇÃO MIOMETRIAL

1º TRIMESTRE

800 mcg via vaginal (4 comprimidos de 200 mcg), intervalo de 3 a 12 horas[1,3,4].

2º TRIMESTRE (13–24 SEMANAS)

400 mcg via vaginal a cada 3 horas; farmacológico seguido do cirúrgico é preferencial ao cirúrgico exclusivo[1].

CICATRIZ UTERINA PRÉVIA

Não ultrapassar **200 mcg vaginais a cada 6 horas** (risco de rotura de 0,28%)[1].

PREPARO CERVICAL

400 mcg vaginais 3 a 4 horas antes do esvaziamento mecânico[1].

CONTRAINDICAÇÕES

Sangramento intenso, sepse de foco uterino, instabilidade — nesses casos, esvaziamento mecânico de primeira escolha. No Brasil, **uso hospitalar exclusivo**.

Método mecânico: a **aspiração intrauterina (AMIU ou elétrica) tem prioridade sobre a curetagem** no primeiro trimestre, por menor morbimortalidade; OMS e FIGO recomendam curetagem *apenas* quando a aspiração não estiver disponível[1,4]. A curetagem permanece como escolha no 2º trimestre, sempre *após* a expulsão fetal induzida por misoprostol[1]. Curetagem de checagem de rotina não é recomendada.

> **CONDUTA PRÁTICA — ABORTAMENTO INFECTADO**
> **Clindamicina 600 mg EV 6/6 h** (ou metronidazol 500 mg EV 8/8 h) **+ gentamicina 3–5 mg/kg/24 h**. Sem resposta: acrescentar ampicilina 1 g EV 6/6 h ou penicilina cristalina 5.000.000 UI EV 6/6 h. Manter EV por **48 h após o último pico febril**. Esvaziamento **mecânico** — misoprostol está fora[1].

Profilaxia anti-RhD

Obrigatória em *qualquer* abortamento, gestação ectópica ou molar em mulher RhD-negativa não sensibilizada: **50 mcg no primeiro trimestre** (sem contraindicação à dose padrão de 300 mcg, mais disponível) e **300 mcg após 12 semanas**, idealmente nas primeiras 72 horas[1,9].

Abortamento recorrente

Clássico: **≥ 3 perdas sucessivas**; a ASRM já considera a partir de **2 perdas clinicamente reconhecidas**. Acomete ~1% dos casais e a causa não é identificada em 40–50%. Investigar anatomia uterina, síndrome **antifosfolipídica** e função tireoidiana[1,10]. Fora da SAF, AAS, heparina, hCG, imunoglobulina e corticoide **não são recomendados**; a didrogesterona oral 10 mg 2–3×/dia mostrou benefício em ensaio randomizado[1].

6.2 Gestação ectópica

Modalidade	Critérios principais	Seguimento
Expectante	Estável; **β-hCG < 2.000** em declínio; massa < 5 cm; sem embrião vivo	β-hCG semanal até negativar
Metotrexato	Estável; sem sinais de rotura; **β-hCG < 5.000**; **massa < 3,5 cm**; sem BCF; hemograma, função hepática e renal normais; adesão ao seguimento	β-hCG no 4º e 7º dia; depois semanal
Salpingostomia	Estável; desejo reprodutivo; β-hCG < 5.000; condições cirúrgicas favoráveis	β-hCG semanal — risco de persistência trofoblástica
Salpingectomia	Rotura, instabilidade, massa maior, β-hCG elevado, prole constituída	Em geral dispensa seguimento seriado

*Tabela 4 — Escolha do tratamento na gestação ectópica[6,13]. **Laparotomia** na instabilidade; **laparoscopia** é a via preferencial na paciente estável.*

Metotrexato

ANTIFOLATO — INIBE A DI-HIDROFOLATO REDUTASE E A PROLIFERAÇÃO TROFOBLÁSTICA

DOSE E VIA

50 mg/m² IM em dose única. Esquemas de dose dupla ou múltiplas doses em títulos mais altos e localizações atípicas[6,13].

MONITORIZAÇÃO

β-hCG no **4º e 7º dia**: queda **≥ 15%** → dosagem semanal até negativar; queda < 15% → nova dose no 7º dia[13].

CONTRAINDICAÇÕES

Instabilidade ou rotura, imunodeficiência, doença hepática, renal ou hematológica ativa, úlcera péptica ativa, amamentação.

EFEITOS ADVERSOS

Estomatite, náuseas, elevação de transaminases, leucopenia, plaquetopenia. Orientar ausência de álcool, AINEs, ácido fólico e relações sexuais durante o tratamento.

ATENÇÃO — DOR APÓS O METOTREXATO

Dor nos primeiros dias é esperada (aborto tubário induzido). **Não** é esperada dor progressiva com repercussão hemodinâmica ou queda de hemoglobina — isso é rotura e indica cirurgia imediata.

6.3 Doença trofoblástica

Pré-esvaziamento: hemograma, tipagem/Rh, β-hCG, TSH e T4 livre (sobretudo se útero > 16 semanas ou β-hCG > 100.000), sorologias, radiografia de tórax e **reserva de 2 unidades de hemácias**[7].

Esvaziamento:vácuo-aspiração é a técnica de escolha; ocitocina apenas *após* a dilatação cervical, pelo risco de **embolização trofoblástica pulmonar**. Anti-RhD independentemente do tipo de mola (o trofoblasto expressa o antígeno RhD). Histerectomia é alternativa em mulheres com ≥ 40 anos e prole constituída — mas **não dispensa o seguimento**[7].

CONDUTA PRÁTICA — SEGUIMENTO PÓS-MOLAR [7]

1. β-hCG quantitativo semanal ou quinzenal até **3 dosagens normais consecutivas**. **2.** Depois, **mensal por 6 meses**. **3.Contracepção eficaz** iniciada logo após o esvaziamento e mantida durante todo o seguimento — nova gestação eleva o hCG e torna a curva ininterpretável. **4.** Mesmo laboratório sempre. **5.** Na alta: ácido fólico, US entre 8 e 10 semanas da próxima gestação e β-hCG 6 semanas após o término de qualquer gestação futura.

Neoplasia trofoblástica gestacional

Diagnóstico **químico-hormonal** — dispensa histopatológico e imagem. Critérios FIGO[7,11]: **platô** (4 ou mais valores estáveis por ≥ 3 semanas: dias 1, 7, 14 e 21); **ascensão** (≥ 10% em ≥ 2 semanas consecutivas: dias 1, 7 e 14); diagnóstico histológico de coriocarcinoma; presença de metástases. Investigação: exame ginecológico (nódulo vaginal violáceo = metástase), USTV com Doppler e radiografia de tórax. Estadiamento FIGO: **escore ≤ 6** → **agente único** (metotrexato ou actinomicina D); **≥ 7 ou estádio IV** → **EMA/CO**. Manter **3 ciclos de consolidação após a negativação** do β-hCG[7].

7

Complicações e situações especiais

Do abortamento: hemorragia com instabilidade, infecção, coagulopatia. **Do esvaziamento:** hemorragia (afastados restos ovulares, considerar uterotônicos e coagulopatia de base) e **perfuração uterina**, cuja conduta é em geral expectante com vigilância[1]. A médio prazo: sinequias (Asherman) e insuficiência istmocervical.

Da ectópica: rotura tubária com choque hemorrágico; persistência trofoblástica após salpingostomia; recorrência (≥ 25% após dois episódios)[6]. **Da DTG:** hipertireoidismo, pré-eclâmpsia precoce, embolização trofoblástica, rotura de cistos teca-luteínicos e evolução para NTG[7].

- **Cicatriz uterina prévia** — limita a dose de misoprostol e levanta a hipótese de gestação em cicatriz de cesárea, de alto risco hemorrágico[1,6].
- **Localizações atípicas de ectópica** (intersticial, cervical, ovariana, abdominal, cicatriz de cesárea) — β-hCG frequentemente > 5.000; manejo em centro com experiência[6].
- **Adolescentes** — rastreio ativo de violência sexual, direito ao sigilo e articulação com a rede de proteção; gestação em menor de 14 anos configura estupro de vulnerável[8].
- **Envio do material para histopatológico é sempre obrigatório** — é a única barreira contra uma mola não diagnosticada[1].

8

Contexto brasileiro e aspectos emocionais

8.1 SUS e legislação

O serviço precisa dispor de **ultrassonografia, aspiração intrauterina e misoprostol**[1]. A indisponibilidade de AMIU em muitos serviços explica a persistência da curetagem no Brasil, apesar da recomendação inversa. O misoprostol é de uso hospitalar exclusivo e sob controle especial.

Aborto legal — três situações[8,14]: risco de vida da gestante (CP, art. 128, I); gestação resultante de estupro (art. 128, II) — **sem exigência de boletim de ocorrência, autorização judicial ou laudo pericial**, bastando o relato registrado em prontuário; e **anencefalia** (STF, ADPF 54, 2012). A Lei nº 12.845/2013 garante atendimento obrigatório e integral no SUS a vítimas de violência sexual[15].

> **ATENÇÃO — SIGILO PROFISSIONAL**
> Profissionais de saúde **não devem comunicar à autoridade policial, judicial ou ao Ministério Público** a situação de abortamento espontâneo ou provocado, por dever legal e ético de sigilo — salvo para proteção da usuária e com o consentimento dela[8]. Isso **não** se confunde com a notificação compulsória de violência nem com a comunicação ao Conselho Tutelar quando a paciente for criança ou adolescente, que são obrigatórias.

8.2 Aspectos sociais e emocionais

Acolher sem impor valores pessoais e crenças, informando apropriadamente, é **componente essencial** do atendimento; a orientação correta reduz a ansiedade e auxilia no luto[1,8]. Isso não é gentileza, é **segurança assistencial**: quem teme julgamento ou denúncia retarda a procura por atendimento — e o atraso é o que mata no aborto inseguro.

- **Luto não reconhecido** — perda sem corpo, sem rito, muitas vezes sem anúncio prévio. O entorno minimiza (“era só o começo”), mas o vínculo não é proporcional à idade gestacional.
- **Culpa** — o sintoma mais previsível e o mais responsível: explicar que 50–60% das perdas decorrem de anomalias cromossômicas aleatórias e que esforço físico, trabalho, relação sexual ou “susto” não causam abortamento é intervenção terapêutica[1].
- **Linguagem** — preferir “perda gestacional” na conversa com a paciente, reservando a terminologia técnica ao prontuário; evitar vocabulário de culpa.
- **Decisão compartilhada** — apresentar opções de tratamento e de alívio da dor devolve algum controle. Não subtratar a dor.
- **Antes da alta** — sinais de alarme por escrito, planejamento reprodutivo (métodos de longa duração podem ser iniciados imediatamente), sinalização de psicologia e serviço social, inclusão do parceiro.

Após perda precoce única não complicada, a evidência (predominantemente observacional) não sustenta exigir período mínimo de espera para nova gestação[5] — exceção formal: após mola, contracepção **durante todo o seguimento**[7].

9

Pontos de prova, pegadinhas e revisão final

Números que caem

Abortamento — < 20–22 sem ou < 500 g · 10% · 50–60% cromossômico · SG ≥ 25 mm sem embrião · CCN ≥ 7 mm sem BCF · misoprostol 800 mcg (1º tri) e 400 mcg 3/3 h (2º tri) · 200 mcg 6/6 h se cicatriz · anti-RhD 50 ou 300 mcg.
Ectópica — 1–2% · 90–95% tubária · β-hCG sobe ≥ 35%/48 h · zona discriminatória 3.500 · expectante < 2.000 · MTX < 5.000 e massa < 3,5 cm · 50 mg/m² IM · queda ≥ 15% entre 4º e 7º dia.
DTG — 1:200–400 no Brasil · MHC 46,XX, NTG 15–20% · MHP 69,XXX, NTG 3–5% · β-hCG > 100.000 sugere MHC · seguimento semanal até 3 normais + mensal por 6 meses · platô 4 valores/3 semanas ou ascensão ≥ 10%/2 semanas · escore ≤ 6 agente único, ≥ 7 EMA/CO.

Pegadinhas

• Saco pequeno vazio ou embrião pequeno sem BCF **não** fecham diagnóstico — repetir a USTV.
• Pseudossaco é **central** e sem vesícula vitelínica; o saco verdadeiro é **excêntrico**.
• Zona discriminatória não é critério diagnóstico de ectópica — é gatilho de investigação; jamais tratar GLI às cegas.
• Misoprostol está **contraindicado** no abortamento infectado.
• **Aspiração > curetagem** no 1º trimestre.
• Pré-eclâmpsia antes de 20 semanas = mola.
• **$p57^{KIP2}$ negativo** = ausência de genoma materno = mola completa.
• NTG dispensa biópsia: o diagnóstico é a curva de hCG.
• Após **salpingostomia**, seguir β-hCG (persistência trofoblástica).
• Ocitocina na mola só **após** a dilatação cervical.
• Não denunciar a paciente à autoridade policial.

Revisão em 30 segundos

Sangrou no primeiro trimestre: cheque **estabilidade**, faça **especular e toque**, peça **β-hCG e USTV**. **Conteúdo no útero** → abortamento; o colo diz qual forma e a US diz se é viável. **Útero vazio com massa anexial** → ectópica; estável decide entre expectante, MTX e cirurgia. **Padrão vesicular com β-hCG altíssimo** → mola; aspira e segue o hCG por meses. Em todos: **anti-RhD se Rh negativo, analgesia, histopatológico, acolhimento sem julgamento e planejamento reprodutivo**.

REFERÊNCIAS

Referências utilizadas

1. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-natal. *Abortamento espontâneo: classificação, diagnóstico e conduta*. Femina. 2025;53(1):47-52. Protocolo Febrasgo de Obstetrícia nº 17.
2. Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, Blaivas M, Barnhart KT, Benacerraf BR, et al. *Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester*. N Engl J Med. 2013;369(15):1443-51.
3. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). *Misoprostol Only Dosing Chart*. Londres: FIGO; 2023.
4. World Health Organization. *Abortion care guideline*. Genebra: WHO; 2022.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. *ACOG Practice Bulletin No. 200: Early Pregnancy Loss*. Obstet Gynecol. 2018;132(5):e197-e207.

6. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Comissão Nacional Especializada em Urgências Obstétricas. *Gravidez ectópica*. São Paulo: Febrasgo; 2021. Protocolo Febrasgo de Obstetrícia nº 15.
7. Braga A, Sun SY, Maestá I, Uberti E. *Doença trofoblástica gestacional*. Femina. 2019;47(1):6-17. Protocolo Febrasgo de Obstetrícia nº 23.
8. Brasil. Ministério da Saúde. *Atenção humanizada ao abortamento: norma técnica*. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2011.
9. Karanth L, Jaafar SH, Kanagasabai S, Nair NS, Barua A. *Anti-D administration after spontaneous miscarriage for preventing Rhesus alloimmunisation*. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(3):CD009617.
10. Regan L, Rai R, Saravelos S, Li TC; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. *Recurrent Miscarriage: Green-top Guideline No. 17*. BJOG. 2023;130(12):e9-e39.
11. FIGO Oncology Committee. *FIGO staging for gestational trophoblastic neoplasia 2000*. Int J Gynaecol Obstet. 2002;77(3):285-7.
12. Connolly A, Ryan DH, Stuebe AM, Wolfe HM. *Reevaluation of discriminatory and threshold levels for serum β-hCG in early pregnancy*. Obstet Gynecol. 2013;121(1):65-70.
13. Elito Junior J, Montenegro NA, Soares RC, Camano L. *Gravidez ectópica não rota: diagnóstico e tratamento. Situação atual*. Rev Bras Ginecol Obstet. 2008;30(3):149-59.
14. Brasil. *Decreto-Lei nº 2.848/1940 — Código Penal*, art. 128; e Supremo Tribunal Federal, *ADPF nº 54*, julgada em 2012.
15. Brasil. *Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013* — atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual.

Doses, valores de corte e critérios devem ser confirmados em bula vigente e nas diretrizes originais. A recomendação sobre intervalo para nova gestação após perda precoce baseia-se predominantemente em evidência observacional.